Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Tympanoplastik

Wiederherstellung des Trommelfells (bei Bedarf mit Rekonstruktion der Gehörknöchelchen und Mastoidektomie)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Seite: ☐ Rechts ☐ Links

Darstellung: ☐ Mikroskopisch ☐ Endoskopisch
☐ Wird während der Operation festgelegt _____

Zugang: ☐ Transkanal (durch den Gehörgang)
☐ Retroaurikulär (hinter dem Ohr) ☐ Endaural _____

Transplantat (Graft): ☐ Muskelhaut (Temporalisfaszie) ☐ Knorpel / Perichondrium
☐ Sonstiges _____

Rekonstruktion der Gehörknöchelchen (Ossikuloplastik): ☐ Nicht geplant ☐ Geplant ☐ Bei Bedarf _____

Mastoidektomie: ☐ Nicht geplant ☐ Geplant ☐ Bei Bedarf _____

Datum und Zusammenfassung des präoperativen Hörtests (Audiogramm): _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Das Trommelfell ist eine dünne Membran, die den Gehörgang vom Mittelohr trennt und die Schallschwingungen an die winzigen Knochen im Mittelohr (Gehörknöchelchen) weiterleitet. Besteht im Trommelfell ein **Loch (Perforation)**, ist das Hörvermögen herabgesetzt, und eindringendes Wasser oder Keime führen zu **wiederkehrendem Ohrenfluss**.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Trommelfellperforationen entstehen meist durch eine **chronische Mittelohrentzündung**, manchmal auch durch eine Verletzung (Ohrfeige, Wattestäbchen, plötzliche Druckänderung). Kleine, frische Löcher können von selbst verheilen; seit Langem bestehende Löcher schließen sich jedoch in der Regel nicht. Bei manchen Patienten hat die Entzündung zudem die Gehörknöchelchen angegriffen oder sich in die luftgefüllten Zellen des Knochens hinter dem Ohr (Mastoid) ausgebreitet. Liegt im Mittelohr ein **Cholesteatom** vor (eine aus Hautzellen bestehende Gewebetasche, die wächst und den Knochen zerstört), ist dessen Behandlung besonders wichtig.

Ziel der Tympanoplastik ist es, das Trommelfell zu verschließen, das Mittelohr von der Entzündung zu befreien, um ein **trockenes und sicheres Ohr** zu erreichen, und nach Möglichkeit **das Hörvermögen zu erhalten oder zu verbessern**.

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation erfolgt in Vollnarkose im Operationssaal unter Verwendung eines Mikroskops und/oder eines Endoskops.

1. **Zugang:** Ist das Loch klein und günstig gelegen, kann die Operation vollständig durch den Gehörgang erfolgen, ohne dass eine sichtbare Narbe bleibt. Bei größeren Löchern oder wenn eine bessere Übersicht erforderlich ist, wird ein kleiner Schnitt hinter dem Ohr (in der Falte hinter der Ohrmuschel) oder vor dem Ohr gesetzt.
2. **Gewinnung des Transplantats:** Zur Wiederherstellung des Trommelfells wird körpereigenes Gewebe verwendet: in der Regel die Hülle des Muskels oberhalb des Ohres (Temporalisfaszie) oder Knorpel der Ohrmuschel mit seiner Knorpelhaut. Diese Gewebe werden über denselben Schnitt oder einen kleinen zusätzlichen Schnitt entnommen.
3. **Säuberung des Mittelohrs:** Die Ränder des Lochs werden angefrischt, das Trommelfell wird angehoben und das Mittelohr untersucht; vorhandenes entzündetes Gewebe und Verwachsungen werden entfernt. Die Gehörknöchelchen werden überprüft.
4. **Rekonstruktion der Gehörknöchelchen (bei Bedarf):** Ist die Gehörknöchelchenkette angegriffen oder unterbrochen, kann sie mit körpereigenem Knochen/Knorpel oder einer gewebefreundlichen Prothese, z. B. aus Titan, wiederhergestellt werden.
5. **Mastoidektomie (bei Bedarf):** Haben sich Entzündung oder Cholesteatom in die luftgefüllten Zellen des Knochens hinter dem Ohr ausgebreitet, werden diese Zellen mit einem speziellen Bohrer eröffnet und ausgeräumt.
6. **Einlegen des Transplantats und Wundverschluss:** Das Transplantat wird unter oder auf das Loch gelegt. Mittelohr und Gehörgang werden mit sich auflösenden Schwämmchen gestützt. Ein eventueller Schnitt wird vernäht, und über dem Ohr wird ein Druckverband angelegt.

Wird ein Cholesteatom festgestellt, kann bei manchen Patienten **6–12 Monate später eine zweite Kontrolloperation (Second-Look-Operation)** geplant werden, um sicherzustellen, dass die Erkrankung vollständig entfernt wurde. Dies wird Ihnen gesondert erläutert.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose	Etwa 1,5–3 Stunden (mit Mastoidektomie länger)	In der Regel ambulant oder 1 Nacht

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Verschluss des Lochs im Trommelfell
- Seltenere oder keine Episoden von Ohrenfluss und Entzündung mehr; ein trockenes und sicheres Ohr
- Weniger Einschränkungen zum Schutz des Ohres beim Baden, Duschen und Schwimmen
- Erhalt oder Verbesserung des Hörvermögens bei geeigneten Patienten
- Bei einem Cholesteatom Entfernung der Erkrankung und Vorbeugung ihrer möglichen schweren Komplikationen

Ein dauerhafter Verschluss des Trommelfells gelingt bei etwa **85–95 %** der Patienten. Eine Verbesserung des Hörvermögens hängt vom Zustand der Gehörknöchelchen, dem Ausmaß der Entzündung und der Gesundheit des

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Innenohrs ab; das Hörvermögen kann sich deutlich verbessern, gleich bleiben oder sich selten verschlechtern. Wächst das Transplantat nicht an oder entsteht ein neues Loch, kann die Operation wiederholt werden.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Beobachtung und Trockenhalten des Ohres:** Bei kleinen, trockenen Löchern können regelmäßige Kontrollen und der Schutz des Ohres vor Wasser eine Möglichkeit sein. Das Loch bleibt offen, und das Entzündungsrisiko besteht weiter.
- **Medikamentöse Behandlung:** Antibiotische Ohrentropfen bringen die Entzündung während Phasen mit Ohrenfluss vorübergehend unter Kontrolle; sie verschließen das Loch nicht.
- **Hörgerät:** Kann den Hörverlust ausgleichen; bei einem laufenden Ohr ist die Nutzung jedoch unter Umständen schwierig, und das Loch wird dadurch nicht verschlossen.
- **Einfache Abdeckung kleiner Löcher:** Bei sehr kleinen Löchern kann ein Verschluss mit einem Papierpflaster oder mit Fettgewebe (Myringoplastik) in Betracht gezogen werden.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne Operation bleibt das Loch im Trommelfell in der Regel offen. Ohrenfluss kann bei Wassereintritt ins Ohr oder bei Infekten der oberen Atemwege wiederkehren, und der Hörverlust kann mit der Zeit zunehmen. Ein unbehandeltes Cholesteatom wächst weiter und kann zu schweren Komplikationen wie **dauerhaftem Hörverlust, Schwindel, Gesichtslähmung, Hirnhautentzündung (Meningitis) oder Hirnabszess** führen.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation wird ein Hörtest (Audiogramm) und bei Bedarf eine Computertomographie (CT) durchgeführt. Sie werden von der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt untersucht.
- In den **6–8 Stunden** vor der Operation dürfen Sie nichts essen und nichts trinken (bitte halten Sie sich an die Anweisungen der Narkoseärztin bzw. des Narkosearztes).
- Wenn das Ohr aktiv läuft, werden Sie möglicherweise gebeten, vor der Operation Tropfen anzuwenden, um das Ohr zu trocknen.
- Am Operationstag können die Haare hinter dem Ohr etwas gekürzt werden. Bei einer Grippe oder Atemwegsinfektion kann die Operation verschoben werden.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 24–48 Stunden	Sie spüren ein Völlegefühl, leichte Schmerzen und ein Verschlussgefühl im Ohr; die Schmerzen werden mit Schmerzmitteln behandelt. Kurzzeitig können leichter Schwindel und

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	Übelkeit auftreten. Der Druckverband wird in der Regel am 1. Tag entfernt. Vermeiden Sie es, auf dem operierten Ohr zu liegen.
Woche 1–2	Wegen der Schwämmchen im Gehörgang ist das Hörvermögen in dieser Zeit **herabgesetzt**; das ist normal. Es kann etwas blutig tingierte Flüssigkeit aus dem Ohr austreten. Die Fäden werden in der Regel am **7.–10. Tag** gezogen. Die meisten Menschen nehmen innerhalb von 1 Woche eine Schreibtischtätigkeit wieder auf.
Woche 3–6	Die Schwämmchen im Gehörgang werden bei den Kontrollen entfernt oder lösen sich von selbst auf. Es darf kein Wasser ins Ohr gelangen. Anstrengender Sport, schweres Heben und Pressen sollten für etwa **4–6 Wochen** aufgeschoben werden. Flugreisen sind in der Regel **nach 2–4 Wochen** mit ärztlicher Zustimmung möglich.
Monat 2–3	Bei den Kontrollen wird beurteilt, ob das Transplantat angewachsen ist. Ein Hörtest in dieser Phase zeigt, wie sich die Operation auf das Hörvermögen ausgewirkt hat. Schwimmen und Wasserkontakt sind in der Regel nach ärztlicher Freigabe erlaubt.
Monat 6–12	Trommelfell und Mittelohr schließen ihre Heilung ab. Nach einer Cholesteatom-Operation werden regelmäßige Kontrollen und bei Bedarf eine Bildgebung oder eine zweite Kontrolloperation geplant.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Völle- und Verschlussgefühl im Ohr sowie in den ersten Wochen ein herabgesetzt wirkendes Hörvermögen (durch die Schwämmchen im Gehörgang)
- Leichte Ohrenschmerzen, Knistern, Schwappgeräusche oder Rauschen
- Leicht blutig tingierter Ausfluss aus dem Ohr (erste Tage)
- Vorübergehendes Taubheitsgefühl an der Ohrmuschel und um den Schnitt; leicht abstehende Ohrmuschel (nach Zugang hinter dem Ohr; bildet sich innerhalb von Wochen zurück)

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Geschmacksveränderung** — Der Geschmacksnerv (Chorda tympani) verläuft direkt hinter dem Trommelfell und kann während der Operation gedehnt werden oder muss selten durchtrennt werden. Etwa **5–20 von 100** Patienten bemerken auf dieser Seite der Zunge einen metallischen Geschmack oder einen verminderten Geschmack bzw. ein Gefühl von Mundtrockenheit; dies **bessert sich meist innerhalb von Wochen bis Monaten oder wird nicht mehr wahrgenommen**. Selten kann es dauerhaft bestehen bleiben.
- **Tinnitus (Ohrgeräusch)** — Nach der Operation kann ein Ohrgeräusch auftreten, oder ein bestehendes Ohrgeräusch kann sich für eine Weile verstärken; dies ist meist vorübergehend.
- **Vorübergehender Schwindel** — In den ersten Tagen können leichte Gangunsicherheit oder Schwindel auftreten; dies klingt meist innerhalb weniger Tage ab.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Gelegentliche Beschwerden

- **Nicht-Anwachsen des Transplantats oder erneutes Loch** — Bei etwa **5–15 von 100** Patienten verschließt sich das Trommelfell möglicherweise nicht vollständig oder es bildet sich später erneut ein Loch. In diesem Fall kann der Ohrenfluss fortbestehen, und **die Operation muss eventuell wiederholt werden**.
- **Keine Verbesserung des Hörvermögens** — Selbst wenn sich das Trommelfell verschließt, verbessert sich das Hörvermögen aufgrund der Gehörknöchelchen, der Belüftung des Mittelohrs oder des Innenohrs möglicherweise nicht wie erwartet. Nach einer Rekonstruktion der Gehörknöchelchen kann sich die Prothese verschieben oder durch das Trommelfell nach außen gedrückt werden; eine weitere Operation kann erforderlich werden.
- **Ohrinfektion und Ohrenfluss** — Nach der Operation können Ohrenfluss oder eine Wundinfektion auftreten; diese heilen meist mit Tropfen oder Antibiotika ab. Eine Entzündung des Ohrknorpels (Perichondritis) ist selten, kann aber eine Verformung des Knorpels hinterlassen.
- **Verengung des Gehörgangs oder Lateralisierung des Trommelfells** — Narbengewebe kann den Gehörgang verengen, oder das neue Trommelfell kann sich von seiner korrekten Position entfernen; dies kann das Hörvermögen beeinträchtigen und einen Korrektureingriff erfordern.
- **Wiederauftreten oder Restbefund eines Cholesteatoms** — Nach einer Cholesteatom-Operation kann die Erkrankung bei einem Teil der Patienten wiederkehren oder ein kleiner Rest weiterwachsen; daher sind eine langfristige Nachsorge und bei Bedarf **eine erneute Operation** erforderlich.
- **Wund- und Narbenprobleme** — Am Schnitt hinter dem Ohr können eine verdickte Narbe oder ein Keloid und selten eine Flüssigkeitsansammlung hinter dem Ohr auftreten.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Dauerhafter Hörverlust durch Schädigung des Innenohrs** — Bei **weniger als 1 von 100** Patienten kann durch eine Beeinträchtigung des Innenohrs eine **dauerhafte Schallempfindungsschwerhörigkeit** entstehen; sehr selten kann das Hörvermögen auf dem operierten Ohr vollständig verloren gehen (Ertaubung). Dies kann ein Hörgerät oder eine weitergehende Hörrehabilitation erforderlich machen. Das Risiko ist bei einem Cholesteatom und bei Erkrankungen in der Nähe des Innenohrs höher.
- **Länger anhaltender Schwindel und Gleichgewichtsstörungen** — Selten kann das Innenohr beeinträchtigt werden, was zu wochenlang anhaltendem Schwindel führt; Gleichgewichtsübungen und Medikamente können erforderlich sein.
- **Lähmung des Gesichtsnervs (Fazialisparese)** — Da der Gesichtsnerv durch das Mittelohr verläuft, kann sehr selten (bei **weit weniger als 1 von 100** Patienten) eine vorübergehende oder dauerhafte Schwäche dieser Gesichtshälfte auftreten. Das Risiko ist bei einem Cholesteatom, bei Wiederholungsoperationen und bei angeboren ungewöhnlichem Nervenverlauf höher. Tritt sie auf, können Medikamente, ein Schutz des Auges und bei Bedarf eine Operation (Druckentlastung oder Wiederherstellung des Nervs) erforderlich sein. Bleibt sie dauerhaft bestehen, können eine Gesichtsasymmetrie und ein unvollständiger Lidschluss zurückbleiben, die einen langfristigen Schutz des Auges und eventuell Operationen zur Wiederherstellung der Gesichtsbewegung (Reanimationschirurgie) erfordern.
- **Komplikationen im Bereich der Hirnhäute** — Insbesondere bei Mastoidektomie und Cholesteatom-Operationen, bei denen der Knochen der Schädelbasis ausgedünnt ist, können sehr selten ein Austritt von Hirnwasser (Liquorleck), eine Hirnhautentzündung (Meningitis) oder eine Verletzung der Hirnhaut auftreten. Dies kann eine weitere Behandlung im Krankenhaus (manchmal auf der Intensivstation) und eine Operation erfordern; eine Meningitis kann selten bleibende Schäden hinterlassen.
- **Dauerhafte Formveränderung der Ohrmuschel** — Infolge des Zugangs hinter dem Ohr oder der Entnahme eines Knorpeltransplantats kann selten eine leichte Veränderung der Stellung oder Form der Ohrmuschel dauerhaft bestehen bleiben.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Plötzlicher, deutlicher Hörverlust** (eine plötzliche Verschlechterung, die sich vom Verschlussgefühl durch die Schwämmchen unterscheidet)
- **Starker Schwindel**, Erbrechen und Unfähigkeit zu stehen
- **Gesichtsschwäche**: herabhängender Mundwinkel, Auge lässt sich nicht schließen
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Ohrenschmerzen, Rötung und Schwellung der Ohrmuschel oder übel riechender, eitriger Ausfluss
- **Klarer, wässriger Ausfluss** aus dem Ohr, starke Kopfschmerzen oder Nackensteifigkeit
- **Nicht stillbare Blutung** aus dem Verband oder dem Ohr

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Bis Ihr Arzt es erlaubt, **darf auf keinen Fall Wasser in Ihr Ohr gelangen**: Verschließen Sie das Ohr beim Duschen mit Watte, die mit Vaseline bestrichen ist; gehen Sie nicht ins Schwimmbad oder ins Meer.
- In den ersten **4–6 Wochen** gilt: **nicht schnäuzen**; wenn Sie niesen müssen, niesen Sie mit offenem Mund. Halten Sie sich nicht die Nase zu, um zu pressen (kein Valsalva-Manöver).
- Vermeiden Sie in den ersten Wochen schweres Heben, Pressen, Bücken und anstrengenden Sport. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie unter Verstopfung leiden.
- Holen Sie für Flugreisen, Tauchen und Aktivitäten mit Druckänderungen unbedingt die Zustimmung Ihres Arztes ein; für das **Tauchen** ist in der Regel eine längere Wartezeit erforderlich.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Führen Sie keine Wattestäbchen oder andere Gegenstände in den Gehörgang ein; wenden Sie die Ihnen verordneten Ohrentropfen wie gezeigt an.
- Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, planen Sie Ihre Rückreise gemeinsam mit Ihrem Arzt; Kontrollen und Hörtests nach Ihrer Rückkehr können bei einem HNO-Arzt vor Ort fortgeführt werden.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine" eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich habe verstanden, dass das Hauptziel der Operation darin besteht, das Trommelfell zu verschließen und ein trockenes, sicheres Ohr zu erreichen; dass eine Verbesserung des Hörvermögens nicht garantiert werden kann und dass sich das Hörvermögen selten verschlechtern kann.
- ☐ Mir wurde erklärt, dass je nach Befund während der Operation eine Rekonstruktion der Gehörknöchelchen oder eine Mastoidektomie erforderlich werden kann, und ich willige ein, dass diese Eingriffe wie oben angekreuzt durchgeführt werden.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein."

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.